

Túi thừa niệu đạo là một **túi hoặc túi nhỏ** hình thành bên cạnh niệu đạo — ống dẫn nước tiểu ra ngoài — hầu hết gặp ở phụ nữ. Nước tiểu có thể đọng lại trong túi, gây chảy nhỏ giọt, khó chịu, nhiễm trùng tái phát hoặc đau khi quan hệ. Bệnh thường bị bỏ sót nhiều năm, nhưng khi được phát hiện thì điều trị rất hiệu quả.

Về tình trạng này

Dấu hiệu điển hình là **"3 chữ D"**:

- **Dribbling (chảy nhỏ giọt)** — rỉ một ít nước tiểu ngay sau khi tiểu xong
- **Dysuria (tiểu buốt)** — cảm giác bỏng rát hoặc khó chịu khi đi tiểu
- **Dyspareunia (đau khi quan hệ)** — đau trong hoặc sau khi quan hệ tình dục

Các dấu hiệu khác gồm **nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) tái phát**, tiểu gấp hoặc tiểu nhiều lần, hoặc có thể sờ thấy một cục mềm đau ở thành trước âm đạo, ấn vào có thể chảy dịch.

Nguyên nhân

Bệnh được cho là bắt đầu khi các tuyến nhỏ quanh niệu đạo bị **tắc và nhiễm trùng**, rồi vỡ vào lòng niệu đạo, tạo ra một túi chứa nước tiểu. Đây không phải ung thư và không do bất kỳ hành động nào của bạn gây ra.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Niệu đạo

Ống dẫn nước tiểu ra khỏi cơ thể.

Túi thừa

Túi hoặc bọc phình ra từ một ống rỗng.

"3 chữ D"

Chảy nhỏ giọt, tiểu buốt và đau khi quan hệ.

MRI

Chụp cộng hưởng từ — phương pháp tốt nhất để xác định vị trí túi trước phẫu thuật.

Cắt bỏ túi thừa

Phẫu thuật cắt bỏ túi và tái tạo niệu đạo.

Vật Martius

Vật mô nhỏ đôi khi dùng để gia cố chỗ khâu sửa chữa.

Nội soi bàng quang

Dùng camera nhỏ để quan sát bên trong niệu đạo và bàng quang.

TÔI CÓ CẦN PHẪU THUẬT KHÔNG? Không nhất thiết. Túi nhỏ không gây triệu chứng có thể chỉ cần theo dõi. Nhưng khi túi gây chảy nhỏ giọt, nhiễm trùng tái phát, đau hoặc khó chịu, thì cắt bỏ túi thừa là phương pháp điều trị dứt điểm. Bác sĩ phẫu thuật sẽ chụp MRI để xác định rõ vị trí và kích thước túi trước khi mổ.

Chẩn đoán như thế nào

- Khám lâm sàng — sờ thấy cục mềm đau ở thành trước âm đạo, ấn vào có thể chảy dịch
- **MRI**, phương pháp tốt nhất để xác định kích thước và hình dạng túi
- Đôi khi cần **nội soi bàng quang** để quan sát lỗ thông từ bên trong

Điều trị như thế nào

- 1 Theo dõi nếu túi nhỏ và không có triệu chứng.
- 2 Điều trị nhiễm trùng trước nếu có.
- 3 **Phẫu thuật cắt bỏ túi thừa** — mổ qua âm đạo để cắt bỏ túi và khâu phục hồi niệu đạo theo từng lớp, đôi khi dùng thêm vật mô nhỏ.
- 4 Sau mổ, **ống thông** được để lại trong khi lành thương; thường chụp **X-quang kiểm tra** trước khi rút ống.

Điều cần biết

- Phẫu thuật khá tỉ mỉ — bạn cần mang ống thông vài tuần sau mổ.
- Đa số bệnh nhân cải thiện rõ rệt; đôi khi túi có thể tái phát hoặc xuất hiện tiểu không kiểm soát nhẹ, có thể được xử lý.
- Phẫu thuật thường được lên kế hoạch sau khi nhiễm trùng đã ổn định.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt, ớn lạnh hoặc đau vùng chậu ngày càng nặng hơn
- **Không thể đi tiểu được**, hoặc ống thông ngừng chảy (sau phẫu thuật)
- Chảy máu nhiều, hoặc rỉ nước tiểu liên tục mới xuất hiện

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Túi thừa niệu đạo là túi nhỏ ở niệu đạo — nhớ “3 chữ D” (chảy nhỏ giọt, tiểu buốt, đau khi quan hệ) và nhiễm trùng tái phát.
2. MRI là phương pháp tốt nhất để xác định túi. Túi nhỏ không triệu chứng có thể theo dõi; túi gây phiền toái sẽ được cắt bỏ cần thận.
3. Sau mổ cần mang ống thông và chụp X-quang kiểm tra. Gọi ngay nếu sốt, không tiểu được hoặc rỉ nước tiểu liên tục.